

13. 用施夹钳取夹时，应注意按照正确的方式进行；且取夹后，应观察产品入钳情况，如出现中心未对准、未充分入钳等情况，应停用，重新取夹。

14. 施夹钳未经消毒，在使用前必须进行清洁和消毒。所有配套器械均推荐使用手工清洁。清洁前拆除所有包装物。建议使用高压蒸汽消毒法对器械进行消毒。按照高压灭菌器的操作方法，用常规高温高压蒸汽法在121℃—123℃处理30min。

15. 手术后立即用流动温水冲洗掉血液、体液及组织。使用中性加酶清洁剂清洗并浸泡至少5min。再用硬塑料刷刷洗器械。请勿用钢丝刷或钢丝绒。在温水中漂洗至少2min。确保器械的所有表面清洁，不残留组织或污渍。将器械保存在经高温高压蒸汽消毒处理的材料或者消毒盒中。

【医疗器械标签所用图形、符号和缩写等内容的解释】

警告	使用前请阅读说明书	有效期	制造商	生产日期	产品编号
不得二次使用	如包装破损切勿使用	无菌	生产批号	经环氧乙烷灭菌	不得二次灭菌

【产品包装】

产品出厂时，初包装采用吸塑盒和透析纸无菌密封包装，内有多枚小包装的一次性闭合夹，应保证产品无菌直至开封。中包装采用纸盒，内附产品合格证、产品使用说明书，外包装采用瓦楞纸箱包装。

【灭菌方式】一次性闭合夹采用环氧乙烷灭菌。

【储存与运输】

储存：包装后的闭合夹应储存在干燥、无腐蚀性气体和通风良好的室内。

运输：包装好的产品可以用正常工具运输，运输时应轻柔，避免阳光直射、剧烈碰撞、雨淋、液体物质浸淋和重力挤压。

【生产日期】详见产品标签

【失效日期】详见产品标签

【生产批号】详见产品合格证

【灭菌批号】详见产品合格证

【有效期】3年

【说明书编制日期】2020年12月10日

【/注册人名称/生产企业名称/售后服务信息】

注册人/生产企业住所：

生产地址：

联系方式：

传真：

邮政编码：

一次性闭合夹使用说明书

【产品名称】一次性闭合夹

【适用范围】一次性闭合夹用于手术中结扎血管、胆囊管或管状组织。如用于胆囊炎、结石性胆囊炎、胆囊息肉患者胆囊切除手术中关闭胆囊管及胆囊动脉。建议选用型号如下表所示：

规格型号	闭合血管和管道组织范围直径（mm）
S（小号）	3mm—10mm
M（中号）	5mm—13mm
L（大号）	7mm—16mm

【型号规格】JZJ-01S、JZJ-02S、JZJ-03S、JZJ-04S、JZJ-05S、JZJ-06S、JZJ-01M、JZJ-02M、JZJ-03M、JZJ-04M、JZJ-05M、JZJ-06M、JZJ-01L、JZJ-02L、JZJ-03L、JZJ-04L、JZJ-05L、JZJ-06L。

【产品结构组成】一次性闭合夹由闭合夹、固定盖和底座组成

【产品性能】

1、尺寸：应符合下表规定

一次性闭合夹型号及基本尺寸

单位：mm

尺寸 型号	a(±0.5)	b(±0.5)	L(±1)	H(±1)	C(±1)	D(±1)
	截面宽度	截面高度	自由张开宽度	高度	臂长1	臂长2
S（小号）	0.8	1.1	10.5	7.6	9.5	9.3
M（中号）	1.2	1.3	14.3	10.4	12.9	12.5
L（大号）	1.3	2.0	17.8	14.2	16.9	16.1

2 外观

（1）一次性闭合夹应形态完整，手感平整，除夹子的内侧（与人体组织接触部分）外，其余部位应平整、无毛刺、飞边、微裂纹、褶皱、缺陷等缺陷。

（2）闭合夹内侧面应有刺状凸点，刺状凸点应清晰、完整，不得有溢角和锋棱等缺陷。

（3）闭合夹外观应光滑，色泽均匀一致，无污渍。

3、化学性能：产品经环氧乙烷灭菌后应无菌。

【使用方法】

1. 根据手术时血管和组织大小，临床医院应判断选择适合的闭合夹。

2. 选择适合的施夹钳进行消毒处理，抓紧施夹钳，并将施夹钳的头部准确的放入闭合夹的底座内，确认头部垂直于底座，轻松的按下施夹钳，直到听到咔嚓声，注意不得强行将施夹钳按入底座或者闭合夹，闭合夹可以轻松的进入和退出底座。

3. 从底座移走施夹钳，确保闭合夹被安全的夹持在施夹钳的咬合面中（如图1所示），夹持底座，保证闭合夹能够被移开。

4. 在使用过程中，定位闭合夹的单齿，确保使用者能用肉眼辨识被结扎的结构。

5. 采取能够提供扣锁装置清晰视野的方式，在被结扎的血管和体腔组织周围定位闭合夹，在施夹钳的手柄上施加足够的力，使其咬合面关闭（如图2所示），闭合夹被锁紧，松开施夹钳的手柄，让施夹

钳退出到合适的位置（如图3、4所示）。

6. 注意：如果血管和体腔组织被剥离，就距闭合夹约2~3mm的位置留置末端边缘，不要将闭合夹一端作为切开导引。

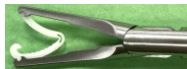


图 1



图 2



图 3



图 4

【除夹钳使用方法】



图 a



图 b



图 c



图 d



图 e

图 a：专用工具——除夹钳

图 b：安放除夹钳。

图 c：对除夹钳手柄施加压力，当除夹钳工作面接触到血管闭合夹时用力对除夹钳施加压力，使结扎血管弧“V”型两臂伸直，锁扣解锁。

图 d：松开除夹钳，此时结扎血管夹由于结构弧度自有的张力，将自动弹开双臂，完成结扎血管夹的除夹。

【注意事项】

1. 医生在使用前应认真阅读本使用说明书。
2. 产品无菌包装破损或已过有效期严禁使用。
3. 本产品在使用时，应严格按照无菌操作要求操作。
4. 一次性闭合夹采用环氧乙烷灭菌，使用前请检查本产品灭菌指示标识，环氧乙烷灭菌后为蓝色指

示标识。

5. 本产品为一次性使用，不得重复灭菌、使用。
6. 在使用闭合夹前，核实血管或组织的结构大小和情况，从而选择合适的闭合夹。
7. 在使用闭合夹前，务必确认闭合夹安装到位，否则钳头的刚性剪切或施力错位可能导致闭合夹无法正常关闭或断裂。
8. 建议使用施夹钳(器)前务必核实所使用的施夹钳(器)规格与闭合夹规格相匹配。
9. 初包装拆开应一次用完，未用完的请销毁！
10. 本产品必须由专业的外科医生操作。
11. 建议腹腔镜镜下供体肾切除手术（禁忌症如下所示）之外的肾动脉结扎的手术，患者端要使用一个以上的闭合夹，并结扎在距离末端边缘最少2~3mm的位置，对于其血管是否需要一个以上闭合夹结扎，则由外科医生根据临床实际判断。
12. 结扎时应避免一次夹入过多的组织，特别是在闭合夹的锁扣装置部位，以免影响闭合夹的结扎性能。
13. 结扎后闭合夹关闭的安全性必须得到确认。
14. 用法详见使用说明。

【禁忌症】

1. 闭合夹不能被用于节育输卵管的闭塞装置；
2. 闭合夹不能被用于腹腔镜下供体的肾切除手术中的肾动脉的结扎；
3. 对本产品成分过敏者，弥漫性黏膜出血者；
4. 瘤性溃疡血管残端需要止血者，因病变部位组织脆弱，闭合夹易脱落；
5. 需要止血部位超出一次性闭合夹适应的夹持的长度，血管直径过大不适合闭合夹的患者；
6. 恶性肿瘤晚期远处转移及免疫抑制或免疫缺陷患者；
7. 残端血管位于病变中央且面积大于3平方厘米的消化道溃疡和出现严重组织坏死的出血者，因闭合夹止血效果欠佳，即使勉强夹住也易因过早脱落而复发。

【警示】

1. 产品仅供已受专业知识和技术培训后的医师和（或）在有相关经验人员的指导下使用。
2. 在未完整阅读使用说明书之前请勿尝试操作该产品，任何的不谨慎操作都将给手术的成功带来风险。
3. 闭合夹应保存于其原始包装内，使用前应检查包装的完整性和有效期限，如果包装已打开或损坏，请勿使用；
4. 不要将闭合夹和施夹钳作为解剖器具；
5. 闭合夹应完全环绕血管和管道组织结扎；
6. 闭合夹不能用于组织标记作用；
7. 闭合夹结构应完好，以便保证合适地结扎血管和管道组织。在操作后检查结扎部位，确认闭合夹的适当闭合。
8. 如果血管和管道组织将被剪断，应在闭合夹与断端之间保留大约2~3mm断端边缘。
9. 闭合夹为一次性使用品，不可重复使用。使用前，手术医生必须熟悉各部件的用途和功能。
10. 闭合夹的配套使用器械为施夹钳(器)。
11. 闭合夹临床使用时建议采用XXX销售公司提供的配套器械。
12. 产品使用后，应按照公认的医院准则对本器械进行废弃处理。